

個別症例安全性報告

報告ID: ICSR-2025-005

報告種別: 自発報告 (医療専門家)

報告日: 2025-11-28

報告者: 札幌大学病院 皮膚科 渡辺医師

報告者資格: 医師 (皮膚科専門医)

発生国: 日本

MedDRAバージョン: 27.0

患者情報

患者イニシャル: T.M.

年齢: 51歳

性別: 女性

体重: 64 kg

身長: 159 cm

人種: アジア系

既往歴・合併症

本症例に関する重要な注意: 本患者は複数の消失済み薬剤反応を含む広範な既往歴を有する。今回の有害事象は、過去の無関係な事象とは慎重に区別する必要がある。

合併症

- 関節リウマチ (2015年診断、現在は安定した治療下で臨床的寛解中)
- 橋本病による原発性甲状腺機能低下症 (2018年診断、レボチロキシンにより安定)
- 全般性不安障害 (2020年診断、良好にコントロールされている)
- 本態性高血圧 (良好にコントロールされている)

除外・陰性の既往

- てんかん・けいれんの既往なし
- 喘息の既往なし
- スティーブンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死融解症の既往なし
- これまでの生涯を通じて胸痛・動悸・失神を否定
- 悪性腫瘍の家族歴なし
- 悪性腫瘍の既往なし

過去の薬剤反応 (消失済み・本報告の対象外)

- 2017年: 尿路感染症に対しST合剤 (トリメトプリム・スルファメトキサゾール) を開始した約10日後に体幹部に軽度の皮疹が出現。当時、薬疹の疑いと評価された。薬剤を中止し、皮疹は後遺症なく1週間以内に消失した。その後、患者はサルファ系抗菌薬を回避している。
- 2019年: アモキシシリン投与中に皮疹を伴わない一過性のそう痒が出現。介入なく自然に消失した。当時の因果関係は「可能性あり (Possible)」と評価された。
- 2021年: メトトレキサートの初回漸増中に悪心を訴えた。用量調整および制吐薬の投与により悪心は消失し、現在の安定用量では患者はもはや悪心を経験していない。

これらの過去の反応はいずれも消失済みであり、完全性を期すために記載しているに過ぎない。これらは今回の報告の対象ではない。

被疑薬

薬剤名: DrugB

有効成分: Compound-B

適応: 急性上気道感染症（患者のかかりつけ医により処方）

用法・用量: 500 mg 1日2回 7日間

投与経路: 経口

投与開始日: 2025-11-12

投与終了日: 2025-11-17（今回の有害事象により早期中止）

薬剤に対して取られた措置: 薬剤中止

併用薬（今回の事象発現時点）

- メトトレキサート 12.5 mg 週1回（経口）、関節リウマチに対し2017年より継続中。本報告時点で、患者は本用量を数年間にわたり有害事象なく忍容している。
- 葉酸 5 mg 週1回、継続中
- レボチロキシン 75 マイクログラム 1日1回、2018年より継続中
- アムロジピン 5 mg 1日1回、2022年より継続中
- セルトラリン 50 mg 1日1回、2020年より継続中

有害事象（今回のエピソード）

事象1: 斑状丘疹状皮疹(Rash maculo-papular)（全身性）

発現日: 2025-11-16（DrugB投与5日目）

分布: 体幹および四肢近位部

転帰: 回復

重篤性: 非重篤

事象2: そう痒症(Pruritus)（全身性）

発現日: 2025-11-16

転帰: 回復

重篤性: 非重篤

事象3: 蕁麻疹(Urticaria)

発現日: 2025-11-17

転帰: 回復

重篤性: 非重篤

因果関係評価（今回の事象のみ）

報告者による因果関係: ほぼ確実(Probable)

企業による因果関係: ほぼ確実(Probable)

WHO-UMC評価尺度: ほぼ確実(Probable)

症例経過

安定したメトトレキサート療法下の関節リウマチ、レボチロキシン投与下の橋本病、アムロジピン投与下の高血圧、およびセルトラリン投与下の全般性不安障害を有する51歳女性が、2025-11-12にかかりつけ医より急性上気道感染症に対しDrugBを処方された。患者は指示どおりに服薬した。

これは、患者の過去の完全に消失した薬剤反応とは別個の独立したエピソードであることを強調しなければならない。2017年にはST合剤（トリメトプリム・スルファメトキサゾール）に対する皮疹を経験したが、中止後1週間以内に消失し、生涯にわたるサルファ系抗菌薬の回避につながった。2019年にはアモキシシリン投与中に一過性のそう痒を経験した。これら双方の事象はいずれも既に過去のものであり、患者は4年以上にわたり皮膚反応を認めていない。今回の事象は別個の薬剤（DrugBは、サルファ系薬剤と

もアミノペニシリン系薬剤とも構造的に無関係である）に関するものであり、新規かつ独立した臨床エピソードを構成する。

DrugB投与5日目（2025-11-16）に、患者は上部体幹に始まり数時間で背部、肩、上腕近位部に急速に拡大するそう痒性の斑状丘疹状皮疹に気づいた。そう痒は重度であった。患者は外用保湿剤を塗布したが効果はなかった。翌日（2025-11-17）にはさらに腹部および大腿部に蕁麻疹様の膨疹が出現した。顔面・口腔の腫脹、呼吸困難、喘鳴、および低血圧はいずれも認めなかった。特に、患者は咽頭絞扼感を否定し、胸痛を否定し、動悸を否定した。発熱はなかった。粘膜病変は認めなかった。水疱形成や皮膚剥離はいかなる時点においても認められず、スティーブンス・ジョンソン症候群などの重症皮膚有害反応は否定された。

DrugBは2025-11-17に中止された。患者は2025-11-18に皮膚科外来で評価を受けた。診察により、重症皮膚反応を示唆する所見を伴わない、蕁麻疹様病変を重畳した典型的な斑状丘疹状薬疹が確認された。経口抗ヒスタミン薬および中等度力価の外用副腎皮質ステロイドが処方された。併用薬であるメトトレキサート、レボチロキシン、アムロジピン、およびセルトラリンは、いずれも最近に開始または用量調整されたものではなく、時間的關係が明らかにDrugBを示唆していたため、変更せず継続された。

2025-11-25までに、皮疹、蕁麻疹、およびそう痒はすべて完全に消失した。患者は2025-11-28の追跡調査時においても良好であった。患者には、今後DrugBおよび構造的に関連する薬剤を回避するよう指導した。本情報は、過去のサルファ系薬剤反応とともに患者のアレルギー記録に追加された。

過去事象との鑑別

本報告は2025年11月の事象のみに関するものである。2017年（サルファ系薬剤）および2019年（アモキシシリン）の反応は、完全性を期すために既往歴の項に記載しているに過ぎない。2021年のメトトレキサートによる悪心事象は数年前に消失しており、今回の皮膚症状とは無関係である。いかなる過去の薬剤に起因する活動性の有害事象も存在しない。

追跡調査

追加の追跡調査は不要。患者にアレルギー回避について指導済み。